VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN

Vũ Văn Giáp - Ngô Quý Châu

MỤC TIÊU

1. *Trình bày được khái niệm, yếu tố nguy cơ của viêm phổi bệnh viện.*
2. *Trình bày được triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của viêm phổi bệnh viện.*
3. *Trình bày chẩn đoán xác định viêm phổi bệnh viện.*
4. *Trình bày được điều trị viêm phổi bệnh viện.*

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ DỊCH TỄ

Viêm phổi bệnh viện là viêm phổi xuất hiện sau khi vào viện 48 giờ mà không có biểu hiện hoặc ủ bệnh tại thời điểm vào viện.

Viêm phổi bệnh viện chiếm 0,5%- 1,0% bệnh nhân nằm viện và là nhiễm trùng gây tử vong cao nhất, tăng thời gian nằm viện từ 7-9 ngày.

Tại các nước châu Á, có khoảng 5-10 ca/1000 dân nhập viện do viêm phổi bệnh viện. Tỉ lệ tử vong do viêm phổi bệnh viên từ 25- 54%.

2. NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ

2.1. Nguyên nhân

Các căn nguyên vi khuẩn gây viêm phổi bệnh viện thường gặp là: *Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae*, chủng *Enterobacter, Acinetobacter baumannii* và *Escheriachia coli*. Tại Việt Nam, theo nghiên cứu tại khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Chợ Rẫy từ năm 2011- 2015, tác nhân gây viêm phổi bệnh viện thường gặp là các vi khuẩn Gram âm.

2.2. Các yếu tố nguy cơ viêm phổi bệnh viện gồm:

- Tuổi cao (> 55 tuổi).
- Bệnh mạn tính.
- Phẫu thuật bụng hoặc ngực.
- Đang có catheter tĩnh mạch hoặc catheter theo dõi áp lực nội sọ liên tục.
- Tăng pH dịch dạ dày (do dùng thuốc ức chế bơm proton, kháng H2 hoặc kháng acid).
- Dùng kháng sinh kéo dài đặc biệt phổ rộng.

testyhoc.vn - Trắc Nghiệm Y Học Trực Tuyến

- Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển.
- Đa chấn thương.
- Liệt.
- Suy dinh dưỡng.
- Suy thận mạn tính.
- Bệnh nhân có các bệnh lý làm tăng nguy cơ hít sặc.

3. TRIỆU CHỨNG

3.1. Lâm sàng

- Viêm phổi bệnh viện xuất hiện sau 48 giờ nhập viện.
- Triệu chứng toàn thân:

+ Bệnh nhân sốt > 38 độ C hoặc hạ thân nhiệt (< 36 độ C).

+ Bệnh nhân ≥ 70 tuổi có thay đổi ý thức mà không thấy nguyên nhân nào khác rõ ràng (ở bệnh nhân cao tuổi triệu chứng thay đổi ý thức thường gặp hơn các triệu chứng đường hô hấp).

- Đờm mủ mới xuất hiện hoặc thay đổi tính chất đờm, hoặc tăng tiết đờm, hoặc cần tăng số lần hút đờm
- Ho mới xuất hiện hoặc nhiều lên hoặc khó thở, hoặc thở nhanh.
- Nghe phổi có ran nổ hoặc ran ẩm, số ít trường hợp có ran ngáy
- Tình trạng trao đổi khí xấu đi: giảm oxy máu (giảm độ bão hoà oxy máu) cần tăng FiO_2 và/hoặc tăng PEEP.

3.2. Xét nghiệm cận lâm sàng

- Công thức bạch cầu: số lượng bạch cầu tăng > 10 giga/lít, hoặc giảm < 4 giga/lít hoặc số lượng bạch cầu non chưa trưởng thành trong máu ngoại vi > 15%.
- Tăng nồng protein phản ứng C.
- Tăng nồng độ procalcitonin máu. Procalcitonin là chất chỉ thị viêm tăng trong trường hợp nhiễm khuẩn mà không tăng trong nhiễm virus. Nồng độ procalcitonin có giá trị trong việc theo dõi đáp ứng điều trị và để quyết định ngừng kháng sinh.
- X-quang ngực thấy tổn thương dạng đám mờ hoặc những nốt mờ mới xuất hiện.
- Cấy máu, cấy vi khuẩn trong đờm do bệnh nhân tự ho khạc, đờm hút qua ống thông vô khuẩn ở vùng hầu họng đối với bệnh nhân ho khạc kém, dịch phế quản để tìm căn nguyên gây viêm phổi.

testyhoc.vn - Trắc Nghiệm Y Học Trực Tuyến

4. TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN

4.1. Chẩn đoán xác định

– Chẩn đoán viêm phổi bệnh viện khi sau 48 giờ kể từ khi nhập viện xuất hiện các dấu hiệu lâm sáng/xét nghiệm và tổn thương trên phim X-quang ngực theo các tiêu chuẩn sau:

– Tổn thương dạng thâm nhiễm, đông đặc, tạo hang mới xuất hiện hoặc tổn thương tiến triển trên phim X-quang phổi và không mất đi nhanh.

– Các dấu hiệu lâm sàng và xét nghiệm máu: ít nhất hai trong các dấu hiệu sau:

+ Nhiệt độ > 38 độ C hoặc < 36 độ C.

+ Số lượng bạch cầu tăng ≥ 12 giga/lít, hoặc giảm ≤ 4 giga/lít.

+ Thay đổi ý thức ở bệnh nhân cao tuổi (> 70 tuổi) đã loại trừ các nguyên nhân khác.

+ Đờm mủ mới xuất hiện hoặc thay đổi tính chất của đờm hoặc tăng tiết đờm, tăng nhu cầu hút đờm.

+ Giảm trao đổi khí (giảm oxy máu, tăng nhu cầu oxy hoặc yêu cầu thở máy).

+ Ho, khó thở, thở nhanh mới xuất hiện hoặc tăng thêm.

+ Ran ẩm, ran nổ hoặc ran rít ngáy ở phổi.

4.2. Nguy cơ nhiễm vi khuẩn đa kháng

Nguy cơ nhiễm vi khuẩn đa kháng trong viêm phổi bệnh viện là điều trị kháng sinh tĩnh mạch trong vòng 90 ngày trước đó.

4.3. Chẩn đoán mức độ nặng

– Viêm phổi bệnh viện là nặng khi có một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Huyết áp tâm thu < 90 mmHg

+ Suy hô hấp (cần thông khí nhân tạo hay cần thở với FiO_2 > 35% để duy trì SpO_2 > 90%.

+ Cần điều trị vận mạch > 4 giờ.

+ Số lượng nước tiểu < 20 ml/giờ hoặc < 80 ml trong hơn 4 giờ.

+ Suy thận cấp cần lọc máu ngoài thận.

+ Hình mờ thâm nhiễm trên X-quang phổi tiến triển nhanh, viêm phổi nhiều thuỳ hay tạo hang.

5. ĐIỀU TRỊ

5.1. Nguyên tắc điều trị

Chỉ định điều trị kháng sinh sớm nhất có thể (trong vòng 1 giờ đầu nếu có kèm sốc nhiễm khuẩn).

testyhoc.vn - Trắc Nghiệm Y Học Trực Tuyến

Theo khuyến cáo của ATS (2016), khi nghĩ tới viêm phổi bệnh viện, nên dựa vào tiêu chuẩn lâm sàng đơn thuần hơn là dựa vào sự thay đổi của các dấu ấn chỉ thị viêm kết hợp tiêu chuẩn lâm sàng để quyết định điều trị kháng sinh ban đầu.

Với điều trị kháng sinh ban đầu theo kinh nghiệm việc lựa chọn kháng sinh cần dựa vào dữ liệu vi khuẩn và độ nhạy cảm kháng sinh của vi khuẩn tại mỗi cơ sở điều trị cụ thể.

Lựa chọn kháng sinh ban đầu dựa trên mức độ nặng của viêm phổi và nguy cơ nhiễm vi khuẩn đa kháng.

5.2. Lựa chọn điều trị kháng sinh ban đầu theo kinh nghiệm

Viêm phổi bệnh viện không phải mức độ nặng và không có nguy cơ nhiễm vi khuẩn đa kháng	Viêm phổi bệnh viện không phải mức độ nặng nhng có nguy cơ nhiễm vi khuẩn đa kháng	Viêm phổi bệnh viện mức độ nặng hoặc điều trị kháng sinh đường tĩnh mạch trong vòng 90 ngày
Một trong các lựa chọn sau: Piperacillin-tazobactam 4,5g truyền tĩnh mạch mỗi 6 giờ Hoặc Cefepime 2g truyền tĩnh mạch mỗi 8 giờ Hoặc Levofloxacin 750mg truyền tĩnh mạch mỗi 24 giờ Hoặc Imipenem 500mg truyền tĩnh mạch mỗi 6 giờ Meropenem 1g truyền tĩnh mạch mỗi 8 giờ	Một trong các lựa chọn sau: Piperacillin-tazobactam 4,5g truyền tĩnh mạch mỗi 6 giờ Hoặc Cefepime hoặc ceftazidime 2g truyền tĩnh mạch mỗi 8 giờ Hoặc Levofloxacin 750mg truyền tĩnh mạch mỗi 24 giờ Ciprofloxacin 400mg truyền tĩnh mạch mỗi 8h Hoặc Imipenem 500mg truyền tĩnh mạch mỗi 6 giờ Meropenem 1g truyền tĩnh mạch mỗi 8 giờ Hoặc Aztreonam 2g truyền tĩnh mạch mỗi 8 giờ Phối hợp Vancomycin 15mg/kg truyền tĩnh mạch mỗi 8 - 12 giờ Hoặc Linezolid 600mg truyền tĩnh mạch mỗi 12 giờ	Hai trong các lựa trọn sau, tránh phối hợp hai loại β- lactam: Piperacillin-tazobactam 4,5g truyền tĩnh mạch mỗi 6 giờ Hoặc Cefepime hoặc ceftazidime 2g truyền tĩnh mạch mỗi 8 giờ Hoặc Levofloxacin 750mg truyền tĩnh mạch mỗi 24 giờ Ciprofloxacin 400mg truyền tĩnh mạch mỗi 8h Hoặc Imipenem 500mg truyền tĩnh mạch mỗi 6 giờ Meropenem 1g truyền tĩnh mạch mỗi 8 giờ Hoặc Amikacin 15-20mg/kg truyền tĩnh mạch mỗi 24 giờ Gentamicin 5-7mg/kg truyền tĩnh mạch mỗi 24 giờ Tobramycin 5-7 mg/kg truyền tĩnh mạch mỗi 24 giờ Hoặc Aztreonam 2g truyền tĩnh mạch mỗi 8 giờ Phối hợp Vancomycin 15mg/kg truyền tĩnh mạch mỗi 8 - 12 giờ Hoặc Linezolid 600mg truyền tĩnh mạch mỗi 12 giờ

testyhoc.vn - Trắc Nghiệm Y Học Trực Tuyến

Các tác nhân gây viêm phổi bệnh viện tại Việt Nam chủ yếu là *Pseudomonas aeruginosa* và các vi khuẩn gram âm do đó cần lựa chọn kháng sinh có phổ tác dụng bao phủ lên các vi khuẩn này.

Đối với các cơ sở điều trị có tỉ lệ nhiễm *Acinetobacter baumannii* đa kháng > 10% nếu viêm phổi bệnh viện có nguy cơ tử vong cao và bệnh nhân không đáp ứng với điều trị sau 48 đến 72 giờ có thể xem xét chỉ định colistin.

Không dùng đơn độc aminoglycoside hoặc colistin trong điều trị viêm phổi bệnh viện.

Thời gian điều trị kháng sinh thông thường kéo dài 7 ngày. Tuy nhiên, thời gian điều trị có thể thay đổi tuỳ thuộc căn nguyên gây bệnh, mức độ cải thiện triệu chứng lâm sàng, X-quang ngực và xét nghiệm máu của từng bệnh nhân.

Theo dõi đáp ứng điều trị viêm phổi bệnh viện được khuyến cáo dựa trên nồng độ procalcitonin phối hợp triệu chứng lâm sàng hơn là dựa trên sự cải thiện triệu chứng lâm sàng đơn độc.

6. CÁC BIỆN PHÁP DỰ PHÒNG VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN

– Vệ sinh bàn tay: tuân thủ quy định của Tổ chức Y tế thế giới về 5 thời điểm cần phải rửa tay.

– Phòng ngừa viêm phổi do hít ở các bệnh nhân hôn mê: đặt bệnh nhân ở tư thế đầu cao 30- 45 độ, vệ sinh răng miệng, dùng ống hút đờm vô khuẩn cho mỗi lần hút đờm, thường xuyên kiểm tra vị trị ống thông dạ dày, kiểm tra thể tích tồn dư của dạ dày để điều trị thể tích và tốc độ nuôi ăn.

– Chăm sóc người bệnh có ống nội khí quản, thông khí nhân tạo: hút sạch chất tiết vùng miệng họng trước khi đặt hoặc rút ống nội khí quản, ngừng cho ăn trước khi rút ống nội khí quản, ưu tiên sử dụng thông khí hỗ trợ không xâm nhập nếu không có chống chỉ định, hạn chế sử dụng an thần, sử dụng nước vô khuẩn cho bộ làm ẩm của máy thở.

– Chăm sóc người bệnh sau mổ: phục hội chức năng hô hấp, ở người bệnh có nguy cơ viêm phổi cao, kiểm soát tốt đau sau mổ.

testyhoc.vn - Trắc Nghiệm Y Học Trực Tuyến

VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG

Vũ Thị Thu Trang - Phan Thu Phương

MỤC TIÊU

1. Trình bày được khái niệm, nguyên nhân và yếu tố thuận lợi của viêm phổi cộng đồng.

2. Trình bày được triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của viêm phổi cộng đồng.

3. Trình bày được chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt viêm phổi cộng đồng.

4. Trình bày được các biến chứng của viêm phổi cộng đồng.

5. Trình bày được điều trị và phòng bệnh viêm phổi cộng đồng.

1. ĐẠI CƯƠNG VÀ ĐỊNH NGHĨA

Viêm phổi cộng đồng là hiện tượng viêm nhiễm của nhu mô phổi bao gồm viêm phế nang, túi phế nang, ống phế nang, tổ chức liên kết khe kẽ và viêm tiểu phế quản tận cùng do các căn nguyên vi khuẩn có nguồn gốc từ cộng đồng (không phải bệnh viện).

Đặc trưng và tổn thương giải phẫu trong bệnh lý viêm phổi là khối đông đặc của nhu mô phổi. Về giải phẫu bệnh người ta chia ra viêm phổi thùy và phế quản phế viêm.

Ngày nay, mặc dù có nhiều kháng sinh hiệu quản song viêm nhiễm cấp tính ở phổi vẫn còn là nguyên nhân tử vong quan trọng ở mọi lứa tuổi đặc biệt ở trẻ em dưới 1 tuổi và người già. Tại Mỹ hàng năm có khoảng 915.900 ca viêm phổi cộng đồng xảy ra ở người lớn tuổi, tỉ lệ bệnh nhân nhập viện là 649/100.000 người và 6,5% bệnh nhân này tử vong. Tại Anh, tỉ lệ viêm phổi cộng đồng phải nhập viện dao động khoảng từ 1,1 đến 2,7/1000 dân số trên 55 tuổi. Tỉ lệ viêm phổi cộng đồng nặng cần phải điều trị tại các đơn vị hồi sức dao động từ 1,2 đến 10/5. Tỉ lệ tử vong do viêm phổi cộng đồng trong vòng 30 ngày ở những bệnh nhân điều trị nội trú có thể lên đến 23% và tỉ lệ tử vong do tất cả nguyên nhân liên quan tới viêm phổi cộng đồng có thể lên đến 28% mỗi năm.

2. CƠ CHẾ BỆNH SINH

2.1. Đường vào

Những tác nhân gây viêm phổi có thể xâm nhập theo những đường vào sau:

– Đường hô hấp:

+ Hít phải vi khuẩn ở môi trường bên ngoài, trong không khí.

testyhoc.vn - Trắc Nghiệm Y Học Trực Tuyến

+ Hít phải vi khuẩn do ổ nhiễm khuẩn đường hô hấp trên.

– Đường máu: thường gặp sau nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, viêm tĩnh mạch nhiễm khuẩn...

– Nhiễm khuẩn theo đường kế cận phổi.

– Đường bạch huyết: Một số vi khuẩn (*Pseudomonas, Klebsiella pneumoniae, S. aureus*) có thể tới phổi theo đường bạch huyết, chúng thường gây viêm phổi hoại tử và áp xe phổi, với nhiều ổ nhỏ đường kính dưới 2cm.

2.2. Cơ chế bảo vệ của phổi

Khi có vật lạ vào phổi, nắp thanh quản đóng lại theo phản xạ. Từ thanh quản đến tiểu phế quản tận cùng có lớp niêm mạc bao phủ bởi các tế bào hình trụ với lông chuyển, những tế bào hình đài tiết ra chất nhầy phủ trên bề mặt niêm mạc. Hệ thống lông chuyển sẽ đẩy lớp nhầy với các vật lạ đã dính kết lên các phế quản lớn, rồi từ đó phản xạ ho sẽ tống các vật lạ ra ngoài. Các globulin miễn dịch có vai trò bảo vệ đường hô hấp: IgA (nồng độ ở đờng hô hấp trên cao hơn ở đường hô hấp dưới) có tác dụng làm ngưng kết vi khuẩn, trung hòa độc tố vi khuẩn, làm giảm khả năng bám dính của vi khuẩn vào niêm mạc. IgG có tác dụng làm ngưng kết vi khuẩn, làm tăng bổ thể, tăng đại thực bào, trung hòa độc tố vi khuẩn, virus, làm dung giải vi khuẩn gram âm. Trong phế nang có nhiều đại thực bào ăn vi khuẩn.

Bạch cầu đa nhân trung tính và tân cầu cũng có những khả năng như trên.

Những người nghiện thuốc lá, thiếu oxy, thiếu máu, rối loạn về bạch cầu bẩm sinh, chức năng thực bào tại phế nang bị suy giảm, hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn gây bệnh.

3. NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CỦA VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG

3.1. Nguyên nhân gây bệnh

Căn nguyên phổ biến gây viêm phổi cộng đồng bào gồm các vi khuẩn điển hình như *Streptococcus pneumoniae, Haemophylus influenzae, Klebsiella pneumoniae* và một số vi khuẩn không điển hình như *Legionella pneumophila, Chlamydia pneumoniae*. Tuy nhiên, tỷ lệ cũng như mức độ đề kháng kháng sinh của các vi khuẩn là khác nhau giữa các quốc gia và khu vực địa lý. Tại Việt Nam, dựa trên các nghiên cứu xác định căn nguyên vi sinh gây viêm phổi cộng đồng, kết quả chó thấy các căn nguyên vi khuẩn thường gặp là *Haemophylus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae* và *Staphylococcus aureus*.

Yếu tố nguy cơ và căn nguyên vi khuẩn gây viêm phổi cộng đồng thường gặp.

testyhoc.vn - Trắc Nghiệm Y Học Trực Tuyến

Yếu tố nguy cơ	Căn nguyên vi sinh thường gặp
Nghiện rượu	Vi khuẩn kị khí trong khoang miệng, *Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae*
Viêm phổi do hít	Vi khuẩn kị khí trong khoang miệng
Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hoặc hút thuốc lá	*Chlamydophila pneumoniae, Haemophylus influenzae, Legionella pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Pseudomomas aerugionsa* hoặc trực khuẩn gram âm khác, *S.pnemoniae.*
Tiếp xúc với dơi hoặc phân chim	*Histoplasma capsulatum*
HIV giai đoạn sớm	*H. influenzae, S.pneumoniae*
HIV giai đoạn umộn	*Aspergilus* và *Cryptococcus, Histoplasma capsulatum, H.influenzae, Nocardia, Pneumocystis jiroveci*
Áp xe phổi	Vi khuẩn kị khí trong khoang miệng, *Staphylococcus aureus* (bao gồm cả MRSA)
Sử dụng các thuốc đường tĩnh mạch	*S. aureus, S.pneumonia*, vi khuẩn kị khí

3.2. Điều kiện thuận lợi

– Thời tiết lạnh, bệnh xảy ra về mùa Đông.

– Cơ thể suy yếu, suy dinh dưỡng, già yếu.

– Nghiện rượu. nghiện thuốc lá

– Chấn thương sọ não, hôn mê.

– Mắc bệnh phải nằm điều trị lâu.

– Biến dạng lồng ngực, gù, vẹo cột sống.

– Bệnh ở tai mũi họng: viêm xoang, viêm amidan.

– Đồng mắc các bệnh như: bệnh hô hấp mạn tính, bệnh lý tim mạch, tai biến mạch não, Parkinson, bệnh thận mạn, bệnh gan mạn, động kinh, sa sút trí tuệ.

4. TỔN THƯƠNG GIẢI PHẪU BỆNH

– Viêm phổi do phế cầu khuẩn thường gặp ở thùy dưới phổi phải nhiều hơn phổi trái, trường hợp bị cả hai bên hiếm gặp hơn.

– Có khi bị nhiều thùy phổi.

– Các giai đoạn viêm phổi thùy cổ điển của Laennec.

4.1. Giai đoạn sung huyết

Vùng phổi bị tổn thương sung huyết mạnh, các mạch máu giãn rộng, thoát hồng cầu, bạch cầu tơ huyết vào phế nang, cấy dịch ở ổ viêm có nhiều vi khuẩn gây bệnh.

testyhoc.vn - Trắc Nghiệm Y Học Trực Tuyến

4.2. Giai đoạn gan hoá đỏ

Sau khi bị bệnh 1-2 ngày, thuỳ phổi bị tổn thương có màu đỏ chắc như gan, cắt mảnh phổi bỏ vào nước thì chìm, trong phế nang chứa nhiều hồng cầu và bạch cầu. Lấy dịch phế nang cấy có nhiều vi khuẩn.

4.3. Giai đoạn gan hóa xám

– Vùng phổi bị tổn thương chắc như gan, màu xám, trên mặt có mủ, trong phế nang có nhiều đại thực bào, hồng cầu và bạch cầu.

– Tổn thương giải phẫu bệnh trong phế quản phế viêm: những vùng tổn thương rải rác cả hai phổi, xen lẫn với những vùng phổi lành, những vùng tổn thương tuổi cũng khác nhau, phế quản bị tổn thương nặng hơn; cắt mảnh phổi bỏ vào nước thì chìm lơ lửng.

5. TRIỆU CHỨNG

5.1. Triệu chứng của viêm phổi thùy

– Triệu chứng toàn thể:

– Bệnh xảy ra đột ngột thường ở người trẻ tuổi, bắt đầu với một cơn rét run kéo dài khoảng 30 phút, rồi nhiệt độ tăng lên 30 - 40^{0}C, mạch nhanh, mặt đỏ, sau vài giờ thì khó thở, toát mồ hôi, môi tím, có mụn herpes ở mép, môi.

+ Ở người già, người nghiện rượu có thể có lú lẫn, ở trẻ con có co giật. Ở người già triệu chứng thường không rầm rộ.
+ Đau ngực: luôn có, đôi khi đau ngực là triệu chứng nổi bật, đau bên tổn thương.
+ Ho khan lúc đầu, về sau ho có đờm đặc, màu gỉ sắt. Có khi nôn mửa, chướng bụng, đau bụng.

– Triệu chứng thực thể:

Trong những giờ đầu, nếu nghe phổi chỉ thấy rì rào phế nang giảm bên tổn thương, sờ và gõ bình thường, có thể nghe thấy tiếng cọ màng phổi và ran nổ cuối thì hít vào.

– Thời kỳ toàn phát: có hội chứng đông đặc:

+ Gõ đục.
+ Rung thanh tăng.
+ Rì rào phế nang mất.
+ Có tiếng thổi ống.
+ Dấu hiệu X-quang: thấy một đám mờ của một thùy hay một phân thùy, có hình tam giác đáy quay ra ngoài, đỉnh quay vào trong.

testyhoc.vn - Trắc Nghiệm Y Học Trực Tuyến



Hình 1.8. Hình ảnh viêm phổi trái- thùy trên có phế quản hơi (air bronchogram) trên phim X-quang.

+ Xét nghiệm:

  • Công thức máu: bạch cầu tăng 15 - 25 giga/lít, 80-90% là bạch cầu đa nhân trung tính.

  • Cấy máu có thể thấy vi khuẩn gây bệnh.

  • Nước tiểu có albumin, có khi có urobilinogen.

Tiến triển

– Sốt duy trì trong tuần đầu, nhiệt độ 38-40^{0}C, khạc đờm mủ đặc.

– Có khi vàng da, vàng mắt nhẹ. Sau một tuần thấy các triệu chứng cơ năng tăng lên, nhưng ngay sau đó thì sốt giảm, đổ mồ hôi, đi tiểu nhiều, bệnh nhân cảm thấy khoan khoái dễ chịu và bệnh khỏi, khám phổi có thể vẫn còn hội chứng đông đặc, hình ảnh X-quang tồn tại trong vài tuần. Nhưng có trường hợp bệnh nhân bị sốc: khó thở, tím môi, mạch nhanh, huyết áp hạ, có khi tử vong do truỵ tim mạch, phù phổi và viêm màng ngoài tim có mủ.

5.2. Triệu chứng phế quản phế viêm

Trong nhiều năm trở lại đây người ta thấy viêm phổi thùy do phế cầu cổ điển giảm đi rất nhiều, trái lại xuất hiện nhiều phế quản phế viêm.

– Viêm phổi thùy khởi phát đột ngột ở người khỏe mạnh, phế quản phế viêm thứ phát trên những bệnh nhân bị các bệnh:

+ Bệnh truyền nhiễm: cúm, sởi, ho gà, sốt, xuất huyết.

+ Bệnh nung mủ mạn tính: nhiễm khuẩn tiết niệu, viêm tai, viêm tuỷ xương, viêm xoang có mủ.

+ Bệnh toàn thể: gầy mòn, già yếu.

+ Ứ đọng phổi: suy tim.

– Triệu chứng:

testyhoc.vn - Trắc Nghiệm Y Học Trực Tuyến

+ Từ từ, sốt nhẹ, $37^0$5 - 38^0C.
+ Đau ngực không rõ rệt.
+ Ho và khạc đờm đặc có mủ.
+ Thời kỳ toàn phát: khó thở nhiều, cánh mũi phập phồng, tím môi.
+ Khám phổi: có vùng đục, rung thanh tăng, nghe có ran nổ, ran ẩm cả hai bên phổi.

– X-quang: có nhiều nốt mờ rải rác hai bên nhất là ở vùng đáy.

– Tiến triển: bệnh thường nặng, nhất là ở trẻ sơ sinh và những người già yếu.

6. CHẨN ĐOÁN

6.1. Chẩn đoán xác định

6.1.1. Chẩn đoán xác định viêm phổi thuỳ dựa vào

– Bệnh khởi phát đột ngột ở người trẻ.

– Có cơn rét run và sốt cao 39^0C - 40^0C.

– Hội chứng nhiễm khuẩn: môi khô, lưỡi bẩn, bạch cầu cao.

– Đau ngực có khi rất nổi bật.

– Ho và khạc đờm màu gỉ sắt.

– Khám phổi: hội chứng đông đặc phổi (gõ đục, rung thanh tăng, rì rào phế nang giảm), tiếng thổi ống.

– X-quang: có hội chứng lấp đầy phế nang với đám mờ đều hình tam giác đáy quay ra ngoài.

– Chụp cắt lớp vi tính: hội chứng lấp đầy phế nang, có hình phế quản hơi.

6.1.2. Chẩn đoán xác định phế quản phế viêm

– Bệnh xảy ra ở trẻ em và người già, sau khi mắc các bệnh: cúm, sởi, ho gà, bạch hầu, suy dinh dưỡng.

– Bệnh khởi phát từ từ. Sốt nhẹ $37^0$5 - 38^0C.

– Khó thở nhiều, cánh mũi phập phồng, tím môi.

– Khám phổi: nghe phổi hai bên có nhiều ran rít và ran nổ từng vùng. Gõ có vùng đục xen lẫn vùng phổi bình thường.

– X-quang: có nhiều nốt mờ rải rác khắp cả hai phế trường, nhất là ở vùng đáy.

testyhoc.vn - Trắc Nghiệm Y Học Trực Tuyến

6.1.3. Chẩn đoán vi sinh

Việc chẩn đoán vi sinh nên được làm trước khi dùng kháng sinh, nhất là ở các trường hợp nặng, bao gồm:

- Đờm: nhuộm soi tươi và cấy.
- Cấy máu.
- Cấy dịch màng phổi.
- Cấy dịch phế quản.
- Các test phát hiện kháng thể như test ngưng kết bổ thể, ngưng kết lạnh...
- Phát hiện kháng nguyên qua nước tiểu.
- PCR (phản ứng khuếch đại chuỗi) với từng loại vi khuẩn riêng biệt.

6.2. Một số thể lâm sàng đặc biệt

- Thể đau bụng cấp: cơn đau bụng cấp như cơn đau bụng gan, cơn đau quặn thận, bụng chướng và sờ vào rất đau, thường xảy ra khi thùy dưới phổi phải bị viêm, có nhiều trường hợp đã phải mổ bụng, cần khám phổi kỹ và chụp X-quang phổi để xác định.

- Thể ỉa chảy: hay xảy ra ở trẻ em, triệu chứng ỉa chảy kéo dài, cần khám phổi và chụp phổi để xác định.

- Thể vàng da, vàng mắt: có khi rất rõ, giống trường hợp viêm gan do virus, cần khám phổi kỹ và chụp phổi để xác định.

6.3. Chẩn đoán phân biệt

- Xẹp phổi: trung thất bị kéo về bên xẹp phổi, cơ hoành nâng lên cao.

- Tràn dịch màng phổi: nhất là vừa có viêm phổi vừa có tràn dịch màng phổi (chọc dò để xác định).

- Nhồi máu phổi: có triệu chứng đau ngực dữ dội, có khi sốc, sốt, ho ra máu, thường xảy ra ở người có bệnh tim, hoặc phẫu thuật vùng hố chậu.

- Áp xe phổi: giai đoạn đầu của áp xe phổi không thể phân biệt được cần hỏi về tiền sử, có phẫu thuật ở vùng mũi họng, nhổ răng... là những nguyên nhân thuận lợi gây áp xe phổi.

- Ung thư phổi: dấu hiệu đầu tiên của ung thư phổi có khi biểu hiện như một viêm phổi - với hội chứng nhiễm khuẩn cấp sau tắc phế quản do ung thư, sau khi điều trị hết nhiễm khuẩn mà tổn thương phổi vẫn còn tồn tại trên một tháng thì nên nghĩ đến ung thư, nhất là người có tuổi, nghiện thuốc lá.

- Giãn phế quản: trường hợp giãn phế quản bị bội nhiễm. Bệnh nhân sốt kéo dài, ho và khạc nhiều, đờm có mủ. Hình ảnh X-quang có khi là một đám mờ không đồng đều giống phế quản viêm một vùng. Bệnh nhân có tiền sử ho và

testyhoc.vn - Trắc Nghiệm Y Học Trực Tuyến

khạc đờm lâu ngày, cần chụp phế quản có lipiodol hoặc chụp cắt lớp vi tính ngực lớp mỏng, độ phân giải cao để xác định.

7. BIẾN CHỨNG

Ngày nay, nhờ có nhiều kháng sinh hiệu nghiệm, tiên lượng bệnh viêm phổi tốt hơn nhiều, tuy vậy những biến chứng của viêm phổi vẫn còn gặp.

7.1. Biến chứng tại phổi

– Tràn khí màng phổi, tràn khí trung thất: thường do nguyên nhân tụ cầu.

– Bệnh lan rộng ra hai hoặc nhiều thùy phổi: bệnh nhân khó thở nhiều hơn, tím môi; mạch nhanh, bệnh nhân có thể chết trong tình trạng sốc.

– Xẹp một thuỳ phổi: do cục đờm đặc quánh làm tắc phế quản một thùy phổi.

– Áp xe phổi: rất thường gặp, do điều kiện kháng sinh không đủ liều lượng, bệnh nhân sốt dai dẳng, khạc nhiều đờm có mủ. X-quang: có một hoặc nhiều hình hang có mức nước, mức hơi.

– Viêm phổi mạn tính: bệnh tiến triển kéo dài, thùy phổi bị tổn thương trở nên xơ hóa.

7.2. Biến chứng ngoài phổi

– Tràn dịch màng phổi: viêm phổi dưới màng phổi gây tràn dịch màng phổi, dịch vàng chanh, số lượng ít, chóng khỏi.

– Tràn mủ màng phổi: bệnh nhân sốt dai dẳng, chọc dò màng phổi có mủ, thờng xảy ra trong trường hợp viêm phổi màng phổi, hoặc do chọc dò màng phổi gây bội nhiễm.

– Viêm màng ngoài tim: triệu chứng đau vùng trước tim, nghe có tiếng cọ màng tim, thường là viêm màng tim có mủ.

7.3. Biến chứng nhiễm khuẩn thứ phát xa hơn

– Viêm nội tâm mạc cấp tính do phế cầu: biến chứng này hiếm gặp, bệnh nhân có cơn sốt rét run, lách to, không phải luôn có triệu chứng van tim.

– Viêm khớp do vi khuẩn: gặp ở người trẻ tuổi, thường chỉ bị một khớp sưng, đỏ, nóng, đau.

– Viêm màng não: là biến chứng hiếm gặp, dịch não tủy đục, áp lực tăng, protein dịch não tủy tăng, glucose giảm, nhiều bạch cầu đa nhân trung tính thoái hóa. Cấy dịch não tủy có thể thấy vi khuẩn gây bệnh.

– Viêm phúc mạc: thường gặp ở trẻ em.

– Viêm tai xương chũm: thường gặp ở trẻ em.

– Viêm thận: ít xảy ra.

– Áp xe não: hiếm gặp.

testyhoc.vn - Trắc Nghiệm Y Học Trực Tuyến

7.4. Biến chứng tim mạch

– Nhịp tim nhanh, ngoại tâm thu và đôi khi rung nhĩ.

– Suy tim: xảy ra trong tình trạng sốc, có tiếng ngựa phi, gan to ứ máu ngoại biên.

– Sốc: hạ huyết áp, hạ nhiệt độ, tím môi, tiên lượng dè dặt.

7.5. Biến chứng tiêu hóa

– Biểu hiện da vàng, vàng mắt do suy gan vì thiếu oxy và tan huyết ở nơi tổ chức phổi bị viêm.

– Có khi biểu hiện liệt hồi tràng, ỉa chảy, nhất là ở trẻ em.

7.6. Biến chứng thần kinh

Vật vã, mê sảng, xảy ra ở người già, người nghiện rượu.

8. YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NẶNG VIÊM PHỔI

Những yếu tố nguy cơ gây tử vong ở bệnh nhân viêm phổi bao gồm: tuổi, tiền sử nghiện rượu, bệnh lý ác tính kèm theo, suy giảm miễn dịch, bệnh thận, suy tim sung huyết và đái tháo đường. Tỷ lệ tử vong cao hơn ở những bệnh nhân nhiễm khuẩn Gram âm, *Staphylococcus aureus*, viêm phổi sau tắc nghẽn trên những bệnh nhân có bệnh lý ác tính, hay viêm phổi do hít phải.

8.1. Đánh giá mức độ nặng của viêm phổi theo tiêu chuẩn Fine

– Để đánh giá mức độ nặng của viêm phổi, Fine và CS (1997) đã đưa ra bảng 19 yếu tố để đánh giá viêm phổi, bao gồm tuổi, giới các bệnh lý kèm theo, các triệu chứng lâm sàng và xét nghiệm.

– Cách phân loại theo tiêu chuẩn Fine như sau:

+ Bệnh nhân tuổi ≤ 50, không có bệnh mạn tính kèm theo (bệnh ác tính, bệnh gan, suy tim, bệnh mạch máu não, bệnh thận), không có biến đổi ý thức, tần số mạch < 125 lần/phút, tần số thở < 30 lần/phút, huyết áp tâm thu ≥ 90 mmHg, nhiệt độ ≥ 35^0C được xếp vào Fine I.

+ Các trường hợp khác, việc xếp loại được tính theo điểm của tiêu chuẩn Fine theo bảng 1.12:

Bảng 1.12. Tiêu chuẩn Fine

Thông số		Điểm
Nhân khẩu học	Nam	Tuổi (năm)
	Nữ	Tuổi (năm) - 10
	Sống ở nhà điều dưỡng	+ 10

testyhoc.vn - Trắc Nghiệm Y Học Trực Tuyến

Thông số		Điểm
Bệnh kèm theo	Ung thư	+ 30
	Bệnh gan	+ 20
	Suy tim sung huyết	+ 10
	Bệnh mạch máu não	+ 10
	Bệnh thận	+ 10
Dấu hiệu thực thể	Biến đổi ý thức	+ 20
	Mạch ≥ 125 L/phút	+ 20
	Thở ≥ 30 L/phút	+ 20
	Huyết áp tâm thu < 90mmHg	+ 15
	Nhiệt độ < 35^0C hay > 40^0C	+ 10
Xét nghiệm và X-quang	pH máu động mạch < 7,35	+ 30
	Creatinine ≥ 145 µmol/L	+ 20
	Natrium < 130 mmol/L	+ 20
	Glucose ≥ 14 mmol/L	+ 10
	Hematocrit < 30%	+ 10
	PaO_2 < 60 mmHg hay SaO_2 < 90%	+ 10
	Tràn dịch màng phổi	+ 10

Bảng 1.13. Phân loại tiêu chuẩn Fine

Tiêu chuẩn	Điểm
Fine I	Không có yếu tố dự báo
Fine II	≤ 70
Fine III	71 - 90
Fine IV	91 - 130
Fine V	> 130

Với Fine I, II, III có thể điều trị ngoại trú; Fine IV, V điều trị nội trú.

Bảng 1.14. Tỷ lệ tử vong theo phân độ Fine

Tiêu chuẩn	Điểm	Số bệnh nhân	Tỷ lệ tử vong (%)
Fine I	Không có yếu tố dự báo	3.034	0,1
Fine II	≤ 70	5.778	0,6
Fine III	71 - 90	6.790	2,8
Fine IV	91 - 130	13.104	8,2
Fine V	> 130	9.333	29,2

testyhoc.vn - Trắc Nghiệm Y Học Trực Tuyến

8.2. Thang điểm CURB 65 đánh giá mức độ nặng của viêm phổi

– Hội Lồng ngực Anh đã đưa ra thang điểm CURB 65 đơn giản và dễ áp dụng, thường được sử dụng trên lâm sàng.

Bảng 1.15. Thang điểm CURB 65 đánh giá mức độ nặng của viêm phổi

Ký hiệu	Chú thích	Tiêu chuẩn
C	Confusion	Thay đổi ý thức
U	Urê máu	Urê máu > 7mmol/lít
R	Respiratory rate	Nhịp thở > 30 lần/ phút
B	Blood pressure	Huyết áp tâm thu < 90mmHg hoặc Huyết áp tâm trơng < 60mmHg
65	Tuổi	Tuổi > 65

– Điểm của mỗi tiêu chuẩn là 0 hoặc 1 điểm, khi tổng điểm CURB 65 từ 0 - 1 điểm thì có thể điều trị ngoại trú; khi tổng điểm CURB 65 ≥ 2 thì nên chuyển bệnh nhân đến bệnh viện, điều trị và theo dõi nội trú. Nếu tổng điểm CURB ≥ 4 nên xem xét điều trị tại khoa Hồi sức.

Bảng 1.16. Tiên lượng tỷ lệ tử vong của viêm phổi dựa vào thang điểm CURB 65

Số yếu tố nguy cơ	Tỷ lệ tử vong (%)	Khuyến cáo nơi điều trị
0	0,7	Ngoại trú
1	2,1	
2	9,2	Nội trú (ngắn hạn)
3	14,5	Nội trú (khoa Hô hấp)
4	40	ICU
5	57	

9. ĐIỀU TRỊ

Theo Antoni Torres và cộng sự năm 2010.

9.1. Bệnh nhân ngoại trú

– Lựa chọn kháng sinh theo căn nguyên gây bệnh, nhưng ban đầu thường theo kinh nghiệm lâm sàng, yếu tố dịch tễ, mức độ nặng của bệnh, tuổi bệnh nhân, các bệnh kèm theo và tác dụng phụ của thuốc.

– Kháng sinh lựa chọn: Macrolide (erythromycin, clarithromycin, hay azithromycin), doxycyclin, hoặc fluoroquinolone (Levofloxacin, Moxifloxacin, Gatifloxacin, hoặc 1 fluoroquinolone có khả năng diệt phế cầu khác).

– Lựa chọn thay thế: Amoxicillin - clavulanic và một số cephalosporin thế hệ 2 (Cefaclor, Cefuroxim, Cepodoxim) thích hợp để diệt *S. pneumoniae* hoặc *H. influenza*. Các thuốc này không có hoạt tính với những vi khuẩn không điển

testyhoc.vn - Trắc Nghiệm Y Học Trực Tuyến

hình. Một số tác giả khuyên dùng macrolide cho những bệnh nhân < 50 tuổi, không có bệnh kèm theo, và fluoroquinolone cho những bệnh nhân > 50 tuổi hoặc có bệnh kèm theo.

9.2. Bệnh nhân nội trú

– Trước điều trị cần lấy bệnh phẩm đường hô hấp, máu, và các bệnh phẩm khác làm chẩn đoán vi sinh và kháng sinh đồ.

– Kết hợp thuốc nhóm β lactam (cefotaxime hoặc ceftriaxone) với nhóm macrolide (erythromycin, clarithromycin, hay azithromycin) hoặc nhóm quinolone (levofloxacin, moxifloxacin, gatifloxacin, hoặc 1 fluoroquinolone có khả năng diệt phế cầu khác). Với những bệnh nhân điều trị tại đơn vị điều trị tích cực, sử dụng 1 thuốc nhóm β-lactam (cefotaxime, ceftriaxone, ampicillin - sulbactam, hay piperacillin- tazobactam), thêm macrolide hoặc fluoroquinolone.

– *Lưu ý:* Với bệnh nhân có bất thường cấu trúc phổi như giãn phế quản, xơ hoá kén... cần quan tâm tới việc dùng những kháng sinh có hoạt tính với *Pseudomonas aeruginosa* như: ceftazidime, cefepime, imipenem, meropenem, mezocillin, piperacillin, piperacillin/tazobactam, ciprofloxacin, aminoglycoside. Khi dị ứng với kháng sinh nhóm β-lactam thì dùng kháng sinh nhóm fluoroquinolone có hoặc không kèm theo clindamycin. Khi nghi ngờ viêm phổi hít phải nên dùng fluoroquinolone, có hoặc không kèm theo β-lactam/ức chế β-lactamase (ampicillin - sulbactam, hay piperacillin- tazobactam), metronidazole hay clindamycin.

– Xem xét thay đổi kháng sinh tuỳ theo diễn biến lâm sàng và kháng sinh đồ nếu có.

9.3. Điều trị triệu chứng

– Chống đau ngực bằng paracetamol, thuốc giảm đau chống viêm nonsteroid, codein, nếu đau quá thì cho morphin 0,01g tiêm dưới da.

– Xét thở máy nếu PaO_2 < 60mmHg, mặc dù đã thở oxy 100%.

– Nếu có truỵ tim mạch: cần đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, truyền dịch (NaCl, glucose đẳng trương) duy trì áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP) từ 5-9 cm H_2O. Nếu huyết áp vẫn thấp < 90mmHg, cần dùng các thuốc vận mạch (dopamin, dobutamin, noradrenalin, adrenalin).

10. NHỮNG THỂ VIÊM PHỔI KHÁC

10.1. Viêm phổi do virus

– Còn gọi là viêm phổi không điển hình, viêm phổi sung huyết - Viêm phổi không điển hình do virus vẹt *(Psittacose),* virus chim *(Ornithose)*, virus *Coxacki, Ricketsi,* sốt Q.

testyhoc.vn - Trắc Nghiệm Y Học Trực Tuyến

– Ngày nay người ta đã phân lập ra được nhiều loại virus gây bệnh hô hấp như *influenza, Adeno - virus, para - influenza virus, Rhino virus, coryza virus* và người ta cũng chế ra đọc nhiều loại vaccin để tiêm phòng bệnh virus hô hấp.

– Tổn thương giải phẫu bệnh học: viêm tiểu phế quản, vách phế quản xâm nhập bạch cầu đa nhân, phế nang chứa dịch viêm và hồng cầu.

– Triệu chứng: bệnh xảy ra trong các vụ dịch: cúm ...

+ Sốt cao 39^0 - 40^0C, mệt mỏi, chán ăn.

+ Khó thở, nhịp tim nhanh.

+ Khạc đờm có mủ.

– X-quang: những đám mờ không đều.

– Xét nghiệm:

+ Công thức máu: số lượng bạch cầu bình thường hoặc giảm.

+ Tốc độ máu lắng tăng.

+ Phản ứng ngưng kết lạnh dương tính.

– Tiến triển: bệnh sẽ khỏi trong vòng 1-2 tuần lễ.

– Điều trị:

+ Điều trị triệu chứng: hạ sốt, giảm đau.

+ Các thuốc chống virus: bệnh nhân nguy cơ cao với các triệu chứng nhiễm cúm điển hình xuất hiện dưới 2 ngày, có dịch cúm: dùng thuốc kháng virus như amantadin, rimantadin hoặc Oseltamivir.

+ Acyclovir cho nhiễm *Herpes simplex*, virus *zona*, virus thủy đậu.

+ Ribavirin cho virus hợp bào hô hấp.

+ Kháng sinh khi có biểu hiện bội nhiễm vi khuẩn

+ Nghỉ ngơi.

10.2. Viêm phổi do tụ cầu

– Giống phế quản phế viêm, nhiều ổ áp xe nhỏ ở phổi có khi nhiều bóng hơi tròn ở 2 phổi. Có thể có tràn khí - tràn mủ màng phổi, hoặc tràn khí trung thất.

– Thứ phát sau nhiễm tụ cầu ở da, có khi xảy ra trong trường hợp nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu.

– Tổn thương giải phẫu bệnh: phế quản phế viêm chảy máu.

– Điều trị: phải dùng kháng sinh liều cao nhất là trong trường hợp nhiễm khuẩn huyết:

+ Oxacillin (Bristopen), methixillin: liều 4-8 g/ngày.

testyhoc.vn - Trắc Nghiệm Y Học Trực Tuyến

+ Cephalosporin thế hệ 3: liều 4-6 g/ngày, 2 kháng sinh trên thường được kết hợp với amikacin liều 10-15mg/kg/ngày.

+ Tụ cầu kháng thuốc hoặc nghi ngờ kháng thuốc: vancomycin liều 2-3g/ngày.

10.3. Viêm phổi do *Klebsiella Pneumoniae*

Bệnh xảy ra ở người già yếu, nghiện rượu, giống phế quản phế viêm.

– Tổn thương giải phẫu bệnh: hoại tử vách phế nang.

– Điều trị: penicillin ít hiệu quả, thường dùng cephalosporin thế hệ 3 phối hợp với nhóm amynoglycosid, nhóm quinolon và chloramphenicol.

10.4. Viêm phổi do *Haemophylus influenzae*

– Bệnh hay gặp ở trẻ em, ít khi ở người lớn. Tổn thương giải phẫu bệnh: viêm tiểu phế quản chảy máu, có khi gây phù phổi do chảy máu.

– Điều trị: penicillin ít hiệu quả, phải cho cephalosporin thế hệ 3, chloramphenicol.

10.5. Viêm phổi do hít phải

– Xảy ra ở người hôn mê, mất ý thức, ngộ độc rượu, gây mê, cho ăn bằng ống thông, có lỗ rò khí quản thực quản, lỗ rò phế quản thực quản.

– Vi khuẩn gây bệnh thường là các vi khuẩn gram âm, yếm khí.

10.6. Viêm phổi do ứ đọng

– Nguyên nhân do ứ đọng mạn tính ở phổi, xảy ra ở người có bệnh tim, suy tim, bệnh nhân nằm lâu ứ đọng làm tắc phế quản và ứ đọng phế nang tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn gây bệnh.

– Nghe phổi có ran ẩm ở hai đáy. X-quang: góc sườn hoành tù.

10.7. Viêm phổi do xạ trị

Xảy ra ở những người xạ trị ung thư phổi. Xuất hiện 1-2 tuần hoặc hàng tháng sau xạ trị. Bệnh nhân xuất hiện khó thở, ho và khạc đờm, có khi tràn dịch màng phổi.

10.8. Viêm phổi sặc dầu

– Nguyên nhân: nhỏ mũi thuốc có dầu, giọt dầu lọt vào phổi, sặc xăng, sặc dầu hỏa, sặc dầu mazut ngày nay rất thường gặp. Bệnh xảy ra ngay sau khi bị sặc. Thường nặng, có thể tiến triển thành hội chứng trụy hô hấp ở người lớn (ARDS): ngay sau sặc dầu, bệnh nhân khó thở dữ dội, tím tái.

– Khám phổi: có hội chứng đông đặc, có khi bị toàn bộ một phổi, nhất là sặc dầu mazut.

testyhoc.vn - Trắc Nghiệm Y Học Trực Tuyến

– X-quang: có hình mờ đều thường là thùy dưới phổi phải.

– Điều trị: cần theo dõi sát, khi có dấu hiệu suy hô hấp, cho thở oxy. Xét đặt nội khí quản cho thở máy chế độ PEEP (áp lực dương cuối thì thở ra) khi có dấu hiệu suy hô hấp.

10.9. Hội chứng Loeffler

– Nguyên nhân: do ấu trùng giun đũa đi qua phổi gây viêm phổi.

– Giải phẫu bệnh: phổi bị xâm nhập bạch cầu ái toan, tương bào và tế bào khổng lồ.

– Triệu chứng: rất kín đáo, sốt nhẹ hoặc không sốt, ho và ít khạc đờm.

– Nghe phổi: ran ẩm, ran nổ, có thể có tiếng cọ màng phổi.

– X-quang: nhiều đám mờ đa dạng và biến đi sau 4-8 ngày.

– Xét nghiệm máu: bạch cầu ái toan tăng 10-20% có khi đến 50%.

– Xét nghiệm đờm có thể thấy ấu trùng giun.

– Xét nghiệm phân: trứng giun.

– Điều trị triệu chứng. Bệnh tự khỏi sau 4-8 ngày.

10.10. Viêm phổi do dịch hạch

– Viêm phổi do dịch hạch thường do tiếp xúc trực tiếp, hít phải trực khuẩn dịch hạch, khoảng 5% dịch hạch thể phổi.

– Bệnh nhân sốt khó thở, ho khạc đờm có máu, xảy ra trong các vụ dịch, tìm vi khuẩn dịch hạch trong hạch và trong đờm. Nếu không được điều trị, tử vong xảy ra sau 2-4 ngày.

– Kháng sinh thường dùng: Streptomycin; chloramphenicol; tetracyclin; Biseptol; Kanamycin; gentamycin.

11. PHÒNG BỆNH

Bệnh viêm phổi và phế quản phế viêm rất phổ biến, số bệnh nhân nằm viện cũng như số bệnh nhân điều trị ngoại trú rất nhiều, đứng hàng thứ hai sau bệnh tiêu hóa. Mặc dù có nhiều kháng sinh hiệu quả nhưng biến chứng và tử vong vẫn còn, vì vậy phòng bệnh là rất quan trọng.

– Điều trị tốt ổ nhiễm khuẩn ở vùng tai mũi họng: viêm xoang có mủ, viêm amidan có mủ, viêm họng, bằng kháng sinh toàn thân hay khí dung.

– Điều trị tốt các đợt nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính như đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản, giãn phế quản.

– Loại bỏ những yếu tố kích thích có hại: thuốc lá, thuốc lào.

– Giữ ấm cổ, ngực trong mùa lạnh.

– Ngày nay người ta đã chế ra vaccin của nhiều loại virus, vi khuẩn để tiêm phòng.

testyhoc.vn - Trắc Nghiệm Y Học Trực Tuyến